

《民法典》角度而言，对格式条款的说明义务应是被动的，即格式合同相对方不询问、格式合同提供方不说明。

实践中，对于保险责任免除条款的明确说明义务应当适用《保险法》第十七条第一款的规定进行主动说明，还是应当适用《民法典》第四百九十六条第二款规定进行被动说明，存有不同意见。笔者认为，就明确说明义务的履行而言，《民法典》规定的是被动的说明义务，《保险法》规定的是主动的明确说明义务，虽然两部法律规定均涉及说明义务，但是说明义务的范围广于明确说明义务，两者概念不完全等同，因此《民法典》并未规定明确说明义务应主动履行还是被动履行，而《保险法》明确规定明确说明义务应当主动履行，故就明确说明义务而言应当适用《保险法》的相关规定，即保险人履行明确说明义务应是积极、主动的，而非消极、被动的。

二、强制还是自选

与传统柜面保险可针对不同投保人的需求进行书面或者口头明确说明不同，互联网保险因保险人采取网页、音频、视频等书面或者口头方式，缺乏面对面的沟通与交流，故相对缺乏针对性。在此情况下，相应的网页、音频、视频等告知方式须以保险合同订立时能够强制投保人阅读或知悉为前提。这也是《保险法》第十七条第一款所规定的明确说明义务应是积极、主动的题中之义。故如果保险合同订立时，相关网页、音频、视频不能在投保人选择投保时强制弹窗或者强制播放并以此作为投保人选择投保的前置程序，而是由投保人自行选择是否阅读或者播放，则应认定保险人没有尽到明确说明义务。

三、“你告知”还是“我阅读”

保险人举证其向投保人尽到明确说明义务的电子投保单、电子保险单或者其他电子保险凭证等证据，往往记载了两大类的文字表述。一类表述为保险人已就相关责任免除条款向投保人进行了解释、说明，投保人已清楚相关责任免除条款的含义，愿意投保，即“你告知”型。另一类表述为投保人已就相关责任免除条款进行了阅读，投保人已清楚相关责任免除条款的含义，愿意投保，即“我阅读”型。

其中，“你告知”型在履行明确说明义务的主动性和程度上强于“我阅读”型。由此，能否理解“我阅读”型不符合明确说明义务的积极、主动履行方式，而认定该种履行方式属于未尽到明确说明义务。

就该问题，笔者认为，不应仅仅拘泥于文字表述，而应明确说明义务的直接目标为尽量实现投保人知悉并清楚相关责任免除条款的含义，从而保障投保人对保险产品的知情权和选择权。因此只要是保险人积极、主动履行明确说明义务的方式，均应予以鼓励和认可。因此，虽然“我阅读”型在履行义务的主动性和程度上不如“你告知”型，但其也是一种积极、主动的履行方式。故对“我阅读”型还需结合具体情况进行判断，而不能一概予以否定。

本案中，盛某甲虽阅读了投保人声明，但不能免除某保险公司向盛某甲履行明确说明义务。此外，根据在案证据，某保险公司所举之证据难以证实其向盛某甲就涉案第2.2.2(4)条保险条款尽到了主动、强制的明确说明义务，应承担举证不利的后果。

编写人：上海金融法院 余甬帆

罹患疾病符合保险合同赔付范围的情况下， 保险公司无权以未提交组织病理学检查报告为由拒赔

—— 陕甲诉某保险公司人身保险合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终6422号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陕甲

被告(上诉人): 某保险公司

【基本案情】

2022年3月21日, 陕甲向某保险公司投保了某重大疾病保险, 被保险人为陕甲, 基本保险金额50万元, 保险期间为终身, 保险费每年8000元, 交费期间为30年。保险条款第2.4条约定, “被保险人于等待期后经我们认可的医院确诊初次患有本合同约定的轻症疾病, 且此前未确诊患有本合同约定的重大疾病, 按基本保险金额的30%给付轻症疾病保险金”。第5.3条申请轻症疾病保险金条款约定, “申请人须提供的特殊证明和资料: 我们认可的医院出具的疾病诊断证明书、病历记录和确诊疾病必要的病理检验、血液检验、影像学检查及其他科学方法的检查报告”。第9.1条约定, “恶性肿瘤-轻度……病灶经组织病理学检查结果明确诊断……且特指下列六项之一: (1) TNM分期为I 期的甲状腺癌” “组织病理学检查指通过局部切除、钳取、穿刺等方法, 从患者机体采取病变组织块, 经过包埋、切片后, 进行病理检查的方法; 通过采集病变部位脱落细胞、细针吸取病变部位细胞等方法获取病变细胞, 制成涂片, 进行病理检查的方法, 属于细胞病理学检查, 不属于组织病理学检查”。保险合同另对豁免保险费进行了约定。

2022年10月3日, 陕甲至江苏某医院进行检查, 得知自己甲状腺及引流区淋巴结彩超提示为甲状腺左叶结节, 医生建议进一步检查。10月14日, 陕甲又至江苏某医院进行检查, 检查部分为甲状腺穿刺, 超声提示为超声引导下甲状腺左叶肿块细针穿刺。次日, 江苏某医院出具细胞报告, 载明陕甲临床诊断为甲状腺肿物、细胞诊断为(甲状腺左叶)乳头状癌。11月6日, 陕甲至无锡某医院进行复诊, 门诊诊断为甲状腺恶性肿瘤。11月14日至12月8日, 陕甲至上海某医院进行治疗, 二次诊断为甲状腺恶性肿瘤; 11月30日, 陕甲进行左叶甲状腺下极背侧乳头状癌射频消融手术。

后陕甲申请保险理赔, 某保险公司于2022年12月13日作出了不予受理通知

书，载明“陕甲因未提供组织病理学检查报告材料，故不予受理，特此通知”。

2023年3月22日，陕甲支付了第二期保费8000元。

【案件焦点】

陕甲未提供组织病理学检查报告材料，保险公司能否依据申请轻症疾病保险金条款不承担保险责任。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市梁溪区人民法院经审理认为：陕甲在保险期间经无锡某医院、上海某医院均诊断为甲状腺恶性肿瘤，上述情况符合案涉保险合同第9.1条约定的轻症疾病之恶性肿瘤-轻度范围。从陕甲入院一系列的医疗检查过程及结果看，其确诊为甲状腺恶性肿瘤的事实客观存在，且按日常逻辑患者在诊疗过程中以治病为目的，患者入院诊断、治疗完全听从于医生的建议和安排，故不能苛求陕甲必须提供组织病理确诊报告以确诊其患恶性肿瘤。陕甲要求某保险公司承担保险责任，符合双方的约定和法律规定。

江苏省无锡市梁溪区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百七十七条，《中华人民共和国保险法》第十条、第二十三条之规定，作出如下判决：

一、某保险公司于本判决发生法律效力之日起五日内向陕甲赔付保险金15万元，并豁免其2022年11月以后剩余各期合同保险费；

二、某保险公司于本判决发生法律效力之日起五日内向陕甲返还保险费8000元。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：陕甲在保险期间经无锡某医院、上海某医院诊断均确诊患甲状腺恶性肿瘤，诊断医院资质符合保险合同约定，故应认为陕甲已经罹患保险合同所列明的疾病。陕甲提供的疾病诊断材料表明其经穿刺病理学检查后诊断为甲状腺恶性肿瘤，该情形与保

险合同中“组织病理学检查”注释的内容并不相悖。此外，保险合同中要求被保险人提供病理学

检查结果的目的是证明其已经罹患保险合同所列明的疾病，病理学检查结果只是证明被保险人罹患疾病属于保险合同规定的理赔范围，不能仅以是否提交病理学检查结果作为拒绝理赔的条件。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于保险合同中申请轻症疾病保险金条款约定投保人理赔时需提供组织病理学检查报告材料，保险公司能否以此免除给付保险金的责任？对此，笔者认为应从以下三方面进行分析：

1. 从举证责任的角度来看。保险案件中，保险权利人仅需就符合理赔条件进行举证。换言之，权利人的证明责任仅限于举证证明保险合同关系成立有效，且请求事项符合保险责任范围。至于是否系免除或减少保险人责任的事由，应由保险人承担举证责任。本案中，保险条款约定理赔需要提供组织病理学检查报告材料，其目的在于证明被保险人罹患疾病属于保险条款约定的“恶性肿瘤-轻度”，即判断是否属于保险责任范围，而陕甲提交的病历、检查报告、手术记录等资料完全可以证明其罹患的疾病属于甲状腺恶性肿瘤，符合保险合同中关于保险责任范围的约定。某保险公司要求陕甲提交组织病理学检查报告才能予以理赔，属于过分加重了保险权利人的证明义务，这既不符合民事诉讼法中关于举证责任的规定，也违背了公平原则及诚实信用原则的要求。

2. 从保险合同中理赔申请条款的合理性来看。《中华人民共和国民法典》第四百九十七条第二项规定，提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，该格式条款无效。关于申请理赔条款是否合理，可以从是否损害权利人的合法权益、是否符合行业规范、是否有违常理等角度进行判断。本案中，陕甲一系列医疗检查结果及手术治疗过程均可确认其患有甲状腺恶性肿瘤，属

于保险责任范围。《健康保险管理办法》第二十二 条规定，保险公司拟定医疗保险产品条款，应当尊重被保险人接受合理医疗服

务的权利，不得在条款中设置不合理的或者违背一般医学标准的要求作为给付保险金的条件。第二十三条规定，保险公司在健康保险产品条款中约定的疾病诊断标准应当符合通行的医学诊断标准，并考虑到医疗技术条件发展的趋势。健康保险合同生效后，被保险人根据通行的医学诊断标准被确诊疾病的，保险公司不得以该诊断标准与保险合同约定不符为理由拒绝给付保险金。故某保险公司要求陕甲必须提供组织病理学检查报告属于设置理赔障碍，且该行为与相关行业规范要求不符，实际上损害了陕甲获得保险金的合法权益，应属不合理条款。

3. 从日常生活实际的角度来看。医学上通常将肿瘤的诊断依据分为5级：临床诊断、专一性检查诊断、手术诊断、细胞病理学诊断、组织病理学诊断，上述诊断依据的可靠性依次递增，组织病理学为最理想的诊断依据。正因如此，人身保险条款中关于肿瘤的判断多要求组织病理学诊断结果。但是，从医学专业角度也可以看出，组织病理学检查并非唯一的检查手段，许多情况下医院也不会进行组织病理学检查，如患者身体情况不允许，或者临床表现典型并经其他几种诊断方式足以确认病情，这些情况就不适合或无必要进行组织病理学检查。本案中，陕甲经多家医院多次诊断为甲状腺恶性肿瘤，并对此进行相应的手术治疗，足以看出其所患疾病符合保险合同约定的理赔标准，不应再苛求其必须提供组织病理学检查材料。另外，患者在诊疗过程中以治病为目的，入院诊断、治疗听从于医生的建议和安排。而且医疗技术的发展日新月异，患者有权选择创伤更小、恢复更快的诊断和治疗方案。

综上，重疾险的理赔不应脱离临床医疗实际，对是否属于保险责任范围的判断应从实际情况出发，以能否准确认定被保险人罹患疾病为标准，避免过分加重被保险人的证明义务。

编写人：江苏省无锡市梁溪区人民法院 窦超

人身保险合同中责任范围条款与免责条款的区分

—— 李某诉某保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市西城区人民法院(2023)京0102民初7927号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：李某

被告：某保险公司

【基本案情】

李某所在的某证券公司作为投保人与某保险公司签订保险协议，被保险人包括李某，重大疾病的保额为80万元。保险合同附件中对疾病的具体定义为，恶性肿瘤一重度，指恶性细胞不受控制地进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位，病灶经组织病理学检查(涵盖骨髓病理学检查)结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版(ICD-10) 的恶性肿瘤类别及《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版(ICD-O-3) 的肿瘤形态学编码属于3、6、9(恶性肿瘤)范畴的疾病。下列疾病不属于“恶性肿瘤一重度”，不在保障范围内(该内容在协议中使用加黑加粗字体显示)：1. ICD-0-3 肿瘤形态学编码属于0(良性肿瘤)、1(动态未定性肿瘤)、2(原位癌和非侵袭性癌)范畴的疾病，如：(1)原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性

癌，肿瘤细胞未侵犯基层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等。2022年7月，李某在某医院进行皮肤病损切除手术，手术削切部分异常甲母质，送病理检查，诊断结果为原位恶性黑色素瘤。后李某以患有保险条款中的“重大疾病一重度”为由向保险公司申请理赔。某保险公司出具通知书，认为李某此次出险原因为“原位恶性黑色素瘤”，属于原位癌，不在重大疾病恶性肿瘤一重度的保障范围内，不予赔付。后李某诉至法院。

【案件焦点】

1. 保险合同中关于限定疾病内容的条款是否属于免责条款；2. 李某所患疾病是否属于保险合同约定的“重大疾病-重度”。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：案涉保险条款附件对重大疾病中“恶性肿瘤-重度”解释为“恶性细胞不受控制地进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位”，并进一步将不符合上述条款的肿瘤形态学编码的疾病如原位癌予以排除。根据该部分约定，原位癌不属于保险合同约定的“恶性肿瘤-重度”的疾病范围，该约定并非对保险责任的特定免除，而是对保险责任范围的约定，属保险责任范围条款，而非责任免除条款。

首先从李某在医院的诊疗过程看，其在该院进行第一次诊疗时组织切除后，病理诊断为原位恶性黑色素瘤。为确认是否扩散，补充进行扩切并进行病理诊断，诊断结果为未见黑色素细胞异常增生。补切组织内未见突破基底膜的恶性黑色素瘤细胞，不属于突破基底膜的浸润性癌，肿瘤细胞尚未增长、侵袭、扩散、转移。其次，从案涉保险条款对于疾病的约定看，经法院与医院核查可知，李某所患疾病已于2022年7月24日被明确诊断为“原位恶性黑色素瘤”，肿瘤形态学和行为学编码可进一步明确为“M8720/2”。因此李某所患肿瘤行为学准确编码应为“/2”，而非“/3”，故李某所患疾病不在保险条款中“恶性肿瘤-重度”范围内，某保险公司无须承担保险责任。

北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十条、第十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第六十七条第一款之规定,判决如下:

驳回原告李某的诉讼请求。

宣判后,李某、某保险公司均未提起上诉,一审判决已生效。

【法官后语】

人身保险合同中通常通过列举方式确定承保疾病种类,并通过“释义”等方式对疾病种类进行定义和说明。该类关于疾病定义条款的性质如何,以及该类条款能够辐射的范围如何确定,其逻辑原点和基础在于厘清免责条款和保险责任范围条款的关系。

一、保险责任范围条款和免责条款的关系

保险责任范围条款是指保险事故发生时,保险人依合同应对被保险人或受益人承担赔偿责任或给付保险金责任的范围条款。免责条款是指保险合同中规定保险公司减轻、免除保险责任的条款,其本质是在保险责任范围内的保险事故发生之后,属于保险责任范围内的、保险公司本应当赔偿或给付的保险金,由于某些特定事由的出现,因此保险公司给付保险金的责任完全或者部分免除。保险责任范围条款和免责条款作为划定保险人责任范围的正、反两面,均是对承保风险范围的具体界定。

保险责任范围条款与免责条款的关系,传统上认为是包含关系,保险责任所指向的责任内容,涵盖责任免除所指向的责任内容,即在保险责任范围之内,保险人不承担赔偿或给付责任方为责任免除^①。但是在保险实践中,保险责任范围条款

^①贾林青教授在《〈保险法〉判案新解》一书(贾林青:《〈保险法〉判案新解》,人民法院出版社2011年版)、潘红艳副教授在《论保险人的免责条款明确说明义务——以对保险行业的实践考察为基础》一文(潘红艳:《论保险人的免责条款明确说明义务——以对保险行业的实践考察为基础》,载《当代法学》2013年第2期)、最高人民法院在《最高人民法院关于保险法司法解释(二)理解与适用》(最高人民法院民事审判第二庭编著:《最高人民法院关于保险法司法解释(二)理解与适用》,人民法院出版社2013年版)中均持该观点。

事实上与免责条款之间的关系不仅限于包含关系，还存在重合、并列等其他关系

。① 二、免责条款的范围界定及审查路径

2009年《中华人民共和国保险法》修订后，将免责条款的范围从“保险人责任免除条款”变更为“免除保险人责任的条款”，使保险法上免责条款范围从“形式标准”跨入“实质标准”。关于如何准确界定免责条款的范围及外延，理论和司法实务中均存在不同意见，主要存在三种观点。第一种观点以实质判断为标准，即保险条款中可能限制或免除保险人给付责任的条款均为免责条款。第二种观点以形式判断为标准，免责条款仅指保险合同中单章约定的“除外责任”，其他章节条款均不是免责条款。第三种观点系折中模式，认为除“除外责任”规定外，散落于其他章节的实际免除或限制保险人责任的部分条款，亦属于免责条款。上述三种观点中，折中模式避免了两种极端化认定，但难点在于如何框定免责条款的识别边界。

事实上，保险责任范围条款与免责条款之间的关系不仅限于包含关系，被保险人或者受益人以相关免责条款不产生效力为由要求保险人给付保险金的，法院应当审查保险条款关于保险责任范围的具体规定，以确定事故是否属于保险责任范围，事故不属于保险责任范围的，无须审查事故是否属于免责范围以及相关免责条款的效力；事故属于保险责任范围的，应进一步审查事故是否属于免责条款规定的情形以及免责条款是否有效。

三、疾病释义条款归入保险责任范围条款或免责条款的考量因素

对于“疾病定义”条款是否属于免责条款，应从以下两个方面予以考察：

第一，“疾病定义”条款是否符合一般公众的通常认知和合理期待。保险合同中会对某些疾病确立一定的标准，只有达到这种标准才被认定为合同约定的重大疾病，有时一般公众理解的重大疾病与保险合同约定的重大疾病并非同

①如本不在保险责任范围条款内的风险，保险合同亦通过免责条款将该等风险明确排除在外，常见情形如意外险中，保险人通常将保险责任范围描述为“被保险人因意外伤害事件造成的死亡伤残，保险人按照合同约定给付保险金”，在责任免除条款中同时约定“被保险人自身疾病所致的死亡和伤残，保险人不承担给付保险金的责任”。

一概念,①如保险公司通过条款约定事实上限缩了保险范围、减轻免除了保险人的责任,并不符合投保人投保的真实意思和公众的合理期待,应当考虑将其认定为免责条款。本案中,原位癌不具备恶性肿瘤的典型特征,故将原位癌排除在重大疾病之外,并未超出一般公众的合理期待。

第二,“疾病定义”条款是否符合通行诊疗规范。世界卫生组织颁布了《疾病和有关健康问题的国际统计分类》,且持续进行修订,并对通行疾病进行了定义。中国保险行业和中国医师协会亦制定了部分重大疾病保险中的疾病定义。参考《健康保险管理办法》第二十三条的规定②,被保险人根据通行的医学诊断标准被确诊疾病的,保险公司不得以该诊断标准与保险合同约定不符为理由拒绝给付保险金。因此,如保险人在通行医学诊断标准之外,在疾病定义条款中另行设置保险范围限制条款,应当认定为属于限制对方责任的免责条款。本案中,对于原位癌不属于恶性肿瘤,无论是依据世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》,还是我国保险行业协会施行的疾病种类定义,都符合通行的诊疗规范,故本案未将其认定为免责条款。

需要说明的是,从保险责任范围条款与免责条款的应然关系出发,应当谨慎、克制地对保险责任范围相关词语的释义条款进行免责条款认定,否则易导致免责条款规制的不当扩大化倾向。尤其是在释义符合通常理解的情况下,不应认为释义条款实际免除了保险人的责任。只有对于超出公众合理期待及通行诊疗规范的疾病定义,才应当被认定为免责条款,并进一步审查免责条款的效力。

编写人:北京市西城区人民法院 田静霆

①如“双耳失聪”限定为“三周岁以上开始理赔”,三周岁以下的保险公司不予理赔;“心脏瓣膜手术”要求实施了“开胸”,通过“微创”进行并非重大疾病;又如“脑外科手术”为全麻下的开颅手术,不包括颅骨钻孔手术和经鼻蝶窦入颅手术,将颅骨钻孔手术排除在外。

②该条内容为,“保险公司在健康保险产品条款中约定的疾病诊断标准应当符合通行的医学诊断标准,并考虑到医疗技术条件发展的趋势。健康保险合同生效后,被保险人根据通行的医学诊断标准被确诊疾病的,保险公司不得以该诊断标准与保险合同约定不符为理由拒绝给付保险金”。

运用“合理期待原则”解释格式化保险合同条款

—— 胡某诉某保险公司人身保险合同案。

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市虹口区人民法院(2023)沪0109民初17944号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告：胡某

被告：某保险公司

【基本案情】

2020年12月31日，案外人甲公司向某保险公司投保团体人身保险。保险单载明保险期间为2021年1月1日0时至12月31日24时，险种包括团体意外伤害保险、团体重大疾病保险等。被保险人清单中包含胡某，所属保障计划对应的重大疾病保险金额为5万元。

重大疾病保险责任条款约定，保险期间内，被保险人因意外首次发病，或在本合同等待期后因非意外的原因首次发病，并在保险人指定或认可的医疗机构由专科医生确诊为本合同所列的一种或多种重大疾病的，保险人按保险单上载明的该被保险人的保险金额给付重大疾病保险金。附表重大疾病定义I型糖尿病：指严重的胰岛素缺乏导致的一组糖、脂肪、蛋白质代谢异常综合征，并且须依赖外源性胰岛素进行机体的葡萄糖代谢和维持生命。本病须经专科医生明确诊断，同时经血胰岛素测定、血C肽测定或尿C肽测定结果证实，并已经

接受了持续的胰岛素治疗180日以上。

胡某于2021年9月7日至A医院入院治疗，当日确诊为I型糖尿病。此后，胡某持续接受胰岛素治疗半年以上。

另查明，胡某于2020年7月15日入职，最后工作日期为2021年10月20日。某保险公司批单载明胡某的减保生效日期为2021年10月20日。

胡某认为，I型糖尿病属于重大疾病，确诊发生在保险期内，故某保险公司应按保单约定给付重大疾病保险金。理赔过程中，某保险公司先是以其使用胰岛素治疗不足半年为由拒赔，至其已接受持续胰岛素治疗满半年，某保险公司又以半年治疗期届满晚于减保生效日期、出险已超出保险期间为由不予赔付。胡某遂起诉请求某保险公司支付保险金5万元。

【案件焦点】

被保险人于保险期间内被确诊I型糖尿病，但接受胰岛素治疗180日以上符合保单重疾险定义时已超出保险期间，该情形是否成立保险责任。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：保险合同关于重大疾病的界定标准及出险认定应当符合医学标准与实践，且应考虑被保险人对重疾确诊的通常理解与对重疾理赔的合理期待。即使保险人在保险合同中通过条款约定确定了承保风险范围，如果被保险人主观上并未理解相关承保范围且依其通常理解可以合理地期待某种风险仍属于保险人的承保范围，尽管这种期待与合同条款约定并不相符，仍有必要保护被保险人的合理期待。本案中，某保险公司经由综合解释保险合同得出I型糖尿病的承保范围和赔付条件，即须满足保险期间内持续接受胰岛素治疗180日以上才能认定出险。而胡某作为被保险人出于通常理解有理由期待一般情况下其如果在保险期间内首次被医院确诊罹患I型糖尿病将获得保险理赔。胡某于2021年9月经医院确诊为I型糖尿病，该确诊事实因未满足持续接受胰岛素治疗180日以上的要求，而不能符合保险合同项下I型糖尿病的出险条件。由此可见，保险合同对于I型糖尿病的界定较医院确诊标准

更为严苛，与实践普遍以医院出具的疾病诊断证明或确诊记录作为疾病确诊依据的通常认知不符，与一般人所理解的持续胰岛素治疗系作为确诊I型糖尿病后的必要治疗手段而非确诊条件的观念亦不相符，有违被保险人对I型糖尿病承保风险范围的合理期待。综上，基于保护被保险人的合理期待，胡某所患疾病符合I型糖尿病的医学定义，某保险公司应承担保险责任。

上海市虹口区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款之规定，判决如下：

某保险公司于本判决生效之日起十日内支付胡某保险金5万元。

宣判后，双方均未上诉，一审判决已发生法律效力。

【法官后语】

在保险业日益发展的当下，保险合同的定型化、格式化特征更为明显。保险人基于所承保的风险种类，以大数法则精算出险概率、厘定保险责任，并设计制定出复杂冗长的保险条款作为保险合同的组成部分。格式化保险条款的广泛实践虽在一定程度上助推了交易的标准化与便捷度，但也极大地冲击了保险缔约的合意基础。保险人长期以来处于制度性优越地位，掌握着保险责任划定与条款设计的主动权。而投保人或被保险人作为外行群体却无法充分理解保险条款，而出险后却要承受相关条款的约束难以获赔。缔约地位的不对等、保险产品信息分布的差异及保险理赔的免责限定等，对投保人及被保险人而言显失公平。“合理期待原则”作为矫正保险产品信息不对称、优先保护被保险人对保险产品风险分散功能的合理化期待的一种新兴合同解释原则，逐渐进入司法视野。现行《中华人民共和国保险法》虽尚未确立该原则，但相关的保险法司法解释已有规则吸收并彰显了这一原则。本案裁判运用合理期待原则对保险责任条款及I型糖尿病定义条款进行解释，有效保障了被保险人的合法权益。

一、新兴的保险合同解释规则：合理期待原则的内涵与特点

所谓“合理期待原则”，是指当保险合同当事人就格式化条款内容的解释发生争议之时，应以投保人或被保险人对于合同缔约目的的合理期待作为出

发点，对相关条款进行解释。相较于传统合同法坚持“明示合同条款须得遵循”

